

Paramètre (biomarqueurs)	Toxique
Ammoniémie ↗	Acide valproïque
ASAT, ALAT ↗	Paracétamol, amanite phalloïde, acide valproïque
Calcémie ↘	Antirouilles (acide oxalique et fluorhydrique)
Chlorures (pseudo-hyperchlorémie)	Bromures
Cholinestérases globulaires/plasmatiques (baisse d'activité)	Insecticides et neurotoxiques organophosphorés
Créatinine ↗	Éthylène glycol
Gazométrie (hémoglobine anormale ou dépression respiratoire)	Monoxyde de carbone (HbCO), Poppers et méthémoglobinisants (MetHb), opiacés (hypoventilation alvéolaire)
Gazométrie artérielle (acidose métabolique)	Salicylés, méthanol, éthylène glycol
Glycémie ↗	↘ Insuline, hypoglycémiants, éthanol, fer
Kaliémie	Chloroquine (↘), digitaliques (↗), théophylline (↘), insuline (↘)
Lactates ↗	Cyanures, hypoglycémiants, éthylène glycol, méthanol
Leucocytoses ↗	Fer
NFS	Méthotrexate
Peptide C ↗	Insuline
Taux de prothrombine ↗, INR ↗	AVK, raticides, colchicine, paracétamol, acide valproïque, amanite phalloïde
TCA ↗, NFS-plaquettes	Héparine et dérivés
TP ↗, NFS-plaquettes	Colchicine
Trou anionique ↗	Éthanol, méthanol, éthylène-glycol, acétone, biguanides
Trou osmolaire ↗	Éthanol, méthanol, éthylène-glycol, acétone

LES PRINCIPAUX TOXIDROMES		
Toxidrome	Symptômes	Substances responsables
Myorelaxation	Coma calme, hypotonie, hyporéflexie, Simple somnolence, dépression respiratoire modérée	Benzodiazépines, zolpidem, zopiclone, barbituriques, méprobamate, phénothiazines sédatives, phénytoïne, valproate de sodium, éthanol
Opioïde	Dépression du SNC, myosis, bradypnée, hypoventilation, bradycardie, hypotension	Héroïne, morphine, codéine, dextropropoxyphène, tramadol, mépéridine, méthadone, fentanyl, clonidine
Anticholinergique (atropinique)	Sécheresse cutanéomuqueuse, soif, hyperthermie, mydriase, tachycardie, rétention urinaire, délire, hallucinations, hyperventilation, agitation	Atropine, belladone, champignons (amanite tue-mouche et panthère), solanacées (datura), antidépresseurs tricycliques, phénothiazines, antihistaminiques, antiparkinsoniens
Cholinergique muscarinique nicotinique central	Sueurs, larmoiement, bronchorrhée, diarrhées, bradycardie, myosis, vomissements Tachycardie, hypertension, fasciculations musculaires, paralysies État confusionnel, ataxie, coma convulsif	Acétylcholine, champignons, nicotine, insecticides carbamates et organophosphorés, neurotoxiques organophosphorés
Sympathomimétique (adrénergique)	Agitation, convulsions, hypertension artérielle, tachycardie, hyperglycémie, hypokaliémie, leucocytose, hyperlactatémie	Caféine, théophylline, amphétamines, cocaïnes, LSD, phencyclidine, éphédrine, théophylline, salbutamol
Sérotoninergique	Dysautonomie, tachycardie, troubles de la conscience, hypertonie, hyperéflexie, myoclonies, rarement hyperthermie	ISRS, IRSNa, agonistes spécifiques de la recapture de la sérotonine
Syndrome malin des neuroleptiques	Hyperthermie, dysautonomie, tachycardie, troubles de la conscience, hypertonie, $\nearrow$ CPK, hyperleucocytose	Neuroleptiques, antipsychotiques
Syndrome extra-pyramidal iatrogène	Akinésie (lenteur dans la coordination des mouvements) Hypertonie (rigidité excessive des muscles) Tremblements : survenant au repos	Tous les médicaments entraînant une diminution de l'activité dopaminergique ou une augmentation de l'activité cholinergique neuroleptiques = antipsychotiques ($\downarrow$ dopa) anticholinesterasiques ($\uparrow$ ach)
Syndrome de sevrage	Insomnie, hallucinations, agitation (convulsions), diarrhée, mydriase, sueurs, chair de poule, tachycardie, crampes	Alcool, opiacés, benzodiazépines, méprobamate
Effet antabuse	Flush cutané (érythème), malaise, tachycardie, céphalées, hypotension, hyperventilation	Disulfirame, dithiocarbamate, phénylbutazone, céphalosporines, champignons (coprins), diméthylformamide, chlorpropamide, nifuroxime, trichloréthylène
Effet stabilisant de membrane (ESM)	Aplatissement onde T, allongement QRS, tachycardies, ESV (extrasystoles ventriculaires), torsades de pointe, bradyarythmie, asystolie	Antiarythmiques, antidépresseurs tricycliques, chloroquine, dextropropoxyphène, bêtabloquants

Pathologie	Neurotransmetteur en cause	Traitements spécifiques
Alzheimer	↘ acétylcholine ↗ Glutamate	Inhibiteurs de la cholinestérase (donépézil, rivastigmine, galantamine) Antagoniste des récepteurs NMDA (mémantine)
Parkinson	↘ dopamine ↗ acétylcholine (altération de l'équilibre dopamine/acétylcholine)	Agonistes dopaminergiques (lévodopa, amantadine) Inhibiteurs de la MAO-B (permet ↗ dopamine) Inhibiteurs de la cathécolO-méthyltransférase (COMT) (permet ↗ dopamine) anticholinergiques
SEP	Excès d'inflammation (auto-immun)	Immunomodulateurs, immunosupresseurs
Migraine	Vasodilatation	Dérivés ergotés (à la fois des agonistes des Rc α-adrénergiques et des Rc 5HTAB/D) Triptans (agonistes des Rc 5HT1B/D)
Épilepsie	↗ Glutamate ↘ GABA	Antiglutamatergique Bloqueurs de canaux Agonistes gabaergiques
Troubles de santé mentale (dépression, trouble obsessionnel compulsif, trouble de stress post-traumatique)	↘ sérotonine	ISRS, ISRN
Anxiété	↘ GABA ↘ sérotonine	Benzodiazépines (activation GABA _A) ISRS au long terme
Manie	↗ dopamine ↗ noradrénaline ↗ glutamate ↘ GABA	Lithium, valproate, lamotrigine
Douleur	↗ glutamate ↗ substance P	
Syndrome malin des neuroleptiques	Blocage des récepteurs dopaminergiques (D2) par des médicaments ou sevrage brutal d'un agoniste dopaminergique ↘ Dopamine brutale	Agoniste D2 (ex : bromocriptine)
Schizophrénie	↗ dopamine voie mésolimbique ↘ dopamine voie mésocorticale	Antipsychotiques = neuroleptiques → Antagonistes D2 (bloquent les récepteurs de la dopamine et réduisent l'hyperactivité dopaminergique pour revenir à la normale)
Syndrome parkinsonien	Inhibition du système dopaminergique due au blocage des récepteurs dopaminergiques par des antipsychotiques	Anticholinergiques (réduisent l'activité cholinergique et rétablissent l'équilibre entre les systèmes cholinergiques et dopaminergiques)